

ESCAPE-THE-GAMES

Camada contínua de apoio entre consultas · uso problemático de apostas e jogos

Ao Dr. Daniel Tornaïm Spritzer

Coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas (GEAT)

Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso (PRO-AMITI)

Instituto de Psiquiatria — HC-FMUSP

Assunto: O seu capítulo mudou uma decisão de desenho no nosso projeto — proposta de colaboração científica

Prezado Dr. Daniel Spritzer,

Escrevo em nome do ESCAPE-THE-GAMES, projeto de software voltado a pessoas em recuperação de uso problemático de apostas e jogos. O motivo direto desta carta é o seu capítulo sobre dependência de jogos eletrônicos em crianças e adolescentes.

Duas passagens dele nos fizeram mudar o produto. A primeira é a de que, ao contrário das dependências de substância, o objetivo de tratamento em jogo eletrônico usualmente não é a abstinência, mas a moderação. A segunda é a de que o tempo de jogo é marcador indireto, já que há jogadores de uso intenso sem prejuízo algum.

Nossa métrica principal era “horas de jogo evitadas”. Depois de ler o capítulo, registramos no repositório que ela está errada para jogo eletrônico — mede o marcador indireto e penaliza quem joga muito sem sofrer dano — e que apostas e jogo eletrônico podem exigir produtos com meta terapêutica diferente. Essa decisão de escopo continua aberta, e é uma das razões de procurarmos vocês.

Procuro o programa não para pedir avaliação de um produto, mas para propor uma colaboração de pesquisa — e para submeter à crítica de vocês uma pergunta que nos parece relevante e que hoje não tem resposta no Brasil.

O QUE CONSTRUÍMOS, E POR QUÊ

Ao estudar o cenário brasileiro, chegamos a uma conclusão que reorientou o projeto: o Estado já entregou a camada episódica do cuidado — a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, o Guia de Cuidado do Ministério da Saúde, a triagem no Meu SUS Digital e o teleatendimento. O que não existe é a camada **contínua**: o que acontece entre uma consulta e a seguinte, quando a pessoa já se autoexcluiu e está sozinha.

É essa camada que estamos construindo: rede de apoio verificada com consentimento em duplo opt-in, plano escrito em estado frio e recuperável no estado quente, preparo do familiar sobre como responder, e telemetria de baixa intrusão. O código é aberto e a métrica que adotamos é deliberadamente hostil ao engajamento — sucesso é a pessoa precisar menos do aplicativo.

POR QUE PROCURAMOS O PROGRAMA DE VOCÊS

Rigor sobre instrumentos. Implementamos o rastreo de três itens derivado da dissertação de Juan David Tovar Velásquez, orientada pelo Prof. Dr. Hermano Tavares, e também a versão brasileira do OGD-Q. Registramos explicitamente, no código e na documentação, o limite declarado pelos próprios autores: a acurácia do primeiro foi estabelecida em apostadores de loteria e não se generaliza para apostadores online. Não usamos nenhum dos dois como diagnóstico. Gostaríamos da orientação de vocês sobre qual instrumento aplicar em qual momento da jornada.

Governança clínica. Nosso módulo de crise está deliberadamente bloqueado para lançamento. Ele não sobe sem diretor clínico responsável nomeado, plantão humano definido e critérios de detecção revisados por quem tem competência para isso. Detectar risco sem ter como responder é a pior combinação possível, e preferimos não lançar a lançar mal.

AS PERGUNTAS

A literatura registra o efeito telescópio — a progressão do jogo social ao patológico sendo substancialmente mais rápida em mulheres do que em homens. A referência brasileira nesse recorte é anterior à aposta online: descreve a era do bingo e do caça-níquel, com amostra clínica. Desde então mudou o que talvez seja a variável mais importante, o acesso.

O efeito telescópio se manteve, encurtou, ou desapareceu depois da aposta online? E ele se comporta do mesmo modo nos dois sexos, quando o cassino cabe no bolso?

A segunda pergunta está mais perto do seu trabalho. A evidência internacional sustenta a migração de loot box para aposta, mas cerca de 80% dos compradores de loot box que apostam não relatam efeito passarela — o que sugere um subgrupo específico, e não uma progressão geral.

A trajetória jogo eletrônico → loot box → aposta online descreve um subgrupo identificável no Brasil? Quem é esse subgrupo aqui?

As duas têm consequência prática direta. Se a janela entre o primeiro sinal e o quadro instalado encolheu, toda estratégia baseada em agir cedo precisa ser recalibrada — inclusive a nossa, hoje desenhada para uma janela que talvez não exista mais. E a segunda exige observar quem **ainda não** chegou ao serviço, que é precisamente onde uma camada contínua alcança e a clínica sozinha não.

O QUE PODEMOS OFERECER

Vocês têm a coorte, os instrumentos validados, o comitê de ética e duas décadas de prática clínica. Nós temos a camada de software que opera continuamente entre as consultas e que pode registrar, com consentimento e sem intrusão, exatamente o tipo de dado longitudinal que esse tipo de pergunta exige.

Colocamos à disposição: o desenvolvimento sem custo de instrumentos de coleta conforme a especificação de vocês; a infraestrutura de registro com trilha de auditoria íntegra, adequada a exigência de comitê de ética; e o código-fonte aberto, auditável por qualquer pessoa. Não buscamos validação comercial, selo, nem exclusividade.

PRÓXIMO PASSO

Se houver interesse, gostaríamos de propor uma conversa de trinta minutos, presencial ou remota, em que apresentáramos o que existe hoje e — mais importante — ouviríamos onde estamos errados. Estamos preparados para descobrir que parte do que construímos não se sustenta clinicamente; é justamente por isso que preferimos ouvir agora, e não depois de lançar.

Agradeço a atenção e coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

Itamar Muniz

ESCAPE-THE-GAMES · Genesis VTS

itamar.muniz@genesis-vts.tech

github.com/Genesis-vts/ESCAPE-THE-GAMES